

Clasificación clínico-anatómica o topográfica

En 1980 Joynt y Shoulson propusieron una clasificación que combinaba los datos semiológicos de las demencias con su localización cerebral. Dividieron los síndromes demenciales en demencias localizadas que comprende la demencia cortical, subcortical y axial, y las demencias globales. El concepto de demencia axial designaba específicamente aquellos cuadros con lesiones diencefálicas o de las estructuras cerebrales mediales, pero dicho término no se ha mantenido en la actualidad (Gustafson, 1992; Alom-Poveda, 1998; Pascual-Millán, 2002). Las demencias corticales se caracterizan por la afectación de las funciones cognitivas que dependen del procesamiento de la neocorteza asociativa. Los síntomas indican un déficit en el procesamiento sensorial (inatención y alucinaciones), en el almacenamiento y recuperación de la información (desorientación y amnesias), en el reconocimiento sensorial (agnosia), en una alteración de la gestualidad intencionada (apraxia), en el procesamiento del lenguaje expresivo y perceptivo (afasia), en la capacidad de razonamiento y pensamiento lógico (abstracción) y/o en la integración de la conducta final del sujeto al medio (alteración conductual). Habitualmente estas demencias muestran dichos déficits cognitivos de forma pura sin acompañarse de otros signos neurológicos. El prototipo de demencias corticales (tabla 2) son la enfermedad de Alzheimer, el grupo de las demencias fronto-temporales y las atrofas focales (Pascual-Millán, 1997; Alom-Poveda, 1998; Robles-Bayón y colaboradores, 2000; Pascual-Millán, 2002).

Las demencias subcorticales designan el deterioro cognitivo por afectación del estriado, tálamo, sustancia blanca subcortical, núcleos del tronco y cerebelo. Dicho término fue aplicado a la clínica por vez primera por Albert y colaboradores en 1974 y ha sido motivo de controversia desde el punto de vista anatómico y neuroquímico y, en ocasiones, se ha considerado que se formulaba a un nivel puramente teórico. Sin embargo, dicho término puede ser defendido como entidad clínica, con signos propios y definidos desde la perspectiva neuropsicológica (Cummings y Benson, 1984; Kaufer y Cummings, 1997; Erkinjuntti y Pantoni, 2000; Barquero-Jiménez, Payno-Vargas y Villanueva-Iza, 2002). Clínicamente se caracteriza por la ausencia de un cuadro afaso-apraxo-agnósico y la alteración de la abstracción. Los síntomas más característicos son la bradipsiquia o enlentecimiento del pensamiento, la apatía, la dismnesia o pseudoalteración de la memoria, alteración de la habilidad para manipular conocimientos adquiridos, alteración de las funciones ejecutivas, cambios emocionales y de la personalidad (apatía, depresión e irritabilidad) y síntomas extrapiramidales marcados. Las enfermedades más características que se asocian con una demencia subcortical (tabla 2) son la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Huntington, el Parkinson-demencia o la enfermedad de Binswanger (Gustafson, 1992; Manubens y Lacruz, 1993; Alom-Poveda, 1998; Pascual-Millán, 2002). Finalmente, las demencias globales, o más recientemente también denominadas mixtas (Kaufer y Cummings, 1997; Peña-Casanova, 1999; Barquero-Jiménez, Payno-Vargas y Villanueva-Iza, 2002), son las que muestran una combinación de síntomas corticales y subcorticales, como ocurre en la mayoría de las demencias en estadios avanzados y en las demencias vasculares (Pascual-Millán, 2002). Algunos autores incluyen también, en

este epígrafe, las demencias fronto-temporales puesto que el lóbulo frontal establece numerosos circuitos fronto-estriados (Kaufer y Cummings, 1997).

	PRIMARIAS		SECUNDARIAS	
	DEGENERATIVAS	NO DEGENERATIVAS	DEGENERATIVAS	NO DEGENERATIVAS
GLOBALES	• Degeneración corticobasal • Demencia mesolímbico-cortical • Demencia en la esclerosis lateral amiotrófica		Leucodistrofias • Leucodistrofia metacromática • Adrenoleucodistrofia	Demencias vasculares • Múltiples infartos cerebrales • Infartos incompletos de sustancia blanca • Infartos de zona frontera • Hematoma cerebral Trastornos tóxico-metabólicos • Síndrome de Korsakoff • Deficiencias (B12...) • Endocrinopatías • Enfermedad de Marchiafava-Bignami • Tóxicos industriales Traumatismos • Demencias post-traumáticas • Demencia pugilística Vírica • Encefalitis herpética

SUBCORTICALES	• Enfermedad de Huntington • Parálisis supranuclear progresiva • Demencia en la enfermedad de Parkinson • Aтроfias multisistémicas • Degeneración talámica selectiva • Gliosis subcortical progresiva • Heterotaxias progresivas degeneraciones espinocerebelosas • Degeneración nigro-estriatal	• Esclerosis múltiple • Calcificaciones idiopáticas de los ganglios basales (Kosaka)	Demencia metabólica • Enfermedad de Wilson	Demencias vasculares • Enfermedad de Binswanger • Estado lacunar • Angiopatía amiloide con hemorragias • Enfermedad colágeno-vasculares con demencia • CADASIL Procesos intracraneales • Hidrocefalia crónica • Neoplasias Demencia infecciosa • Demencia SIDA • Enfermedad de Whipple • Neurosífilis • Leucoencefalopatía multifocal progresiva Demencia metabólica • Encefalopatía hepática
----------------------	---	---	---	---

Clasificación de las principales demencias de acuerdo con los criterios clínico-anatómicos, evolutivo-terapéuticos y etiopatogénicos (Deus y colaboradores, 2004). Abreviaciones. DFT: demencia fronto-temporal; CADASIL: arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía.

Clasificación evolutivo-terapéutica

En 1981 Strub y Black propusieron este sistema de clasificación puesto que algunas de las causas de demencia son curables, si bien son las menos frecuentes, y otras pueden tratarse, como mínimo, para mejorar su evolución y aliviar sus síntomas. Así, este sistema de clasificación incorpora información acerca del pronóstico y su curso, así como del potencial terapéutico, pudiéndose diferenciar tres tipos de demencias (Bulbena, 1991; Junqué, 1994) que Kaufer y Cummings las engloban en dos subgrupos. El primero, denominado no degenerativas, incluye a las demencias tratables y potencialmente reversibles y a las demencias tratables e irreversibles. Las demencias tratables y potencialmente reversibles son síndromes demenciales producidos por una serie de trastornos que, si son diagnosticados y tratados a tiempo, pueden remitir. En este grupo se incluyen enfermedades metabólicas y carenciales, intoxicación por drogas y metales, enfermedades infecciosas, vasculitis y procesos intracraneales. Las demencias tratables e irreversibles que consideran aquellos trastornos crónicos que producen demencia y cuyo tratamiento resulta eficaz a nivel paliativo. En este bloque se ubican las demencias vasculares, la postraumática y las alcohólicas. Finalmente, el tercer grupo son las demencias no tratables e irreversibles, o degenerativas, que quedan definidas como aquellos síndromes demenciales que no tienen tratamiento, por lo que su evolución suele ser a menudo crónica e irreversible. En dicho grupo se incluyen la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia cortical, o las enfermedades de Pick o de Huntington, entre otras.

Clasificación etiopatogénica

El conocimiento de la causa o etiología de la demencia es fundamental (Cambier, Masson y Dehen, 2000), puesto que constituye la única forma de establecer una terapia y un pronóstico específico para cada caso (Kaufer y Cummings, 1997; Peña-Casanova, 1999b). Bouchard y Rossor (1996) simplificaron las causas principales de deterioro progresivo de las funciones cognitivas en cuatro grupos: enfermedades generales (tales como la hipertensión, la diabetes o las anemias entre otras), enfermedades mentales o psiquiátricas, enfermedades neurológicas con demencia secundaria y demencias degenerativas cerebrales primarias. Otros autores las engloban en tres grupos (Manubens y Lacruz, 1993; Robles-Bayón, Carnero-Pardo, Pascual-Millán y colaboradores, 2000): demencias primarias o degenerativas (DDP), demencias secundarias o sintomáticas y demencias combinadas o de etiología múltiple. En las DDP, el factor fisiopatológico principal radica en la hipofunción o pérdida de neuronas y sinapsis debido a alteraciones intrínsecas en el metabolismo neuronal con una característica topográfica implicada y un curso clínico irreversible (Kaufer y Cummings, 1997; Pascual-Millán, 2002). En este grupo destacan, en primera instancia, las DDP corticales, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy-difusos (DCLD), las DDP con inicio focal y el grupo de demencias fronto-temporales o complejo-Pick. En segundo lugar, se incluyen las DDP subcorticales, tales como la enfermedad de Huntington, entre otras. En las demencias secundarias o enfermedades que cursan con demencia (Junqué, 1994), el factor patogénico principal es también una disfunción o pérdida neuronal, aunque por causas externas al metabolismo neuronal, como por ejemplo los trastornos vasculares, los procesos infecciosos o los trastornos endocrinos, metabólicos o carenciales (Cambier, Masson, Dehen, 2000; Pascual-Millán, 2002). Son demencias, en algunos casos, potencialmente reversibles de acuerdo con su etiología y, por tanto, no degenerativas (Kaufer y Cummings, 1997). En las demencias combinadas existe

a la vez más de una causa suficiente para originar el síndrome demencia. El tipo más frecuente es la demencia mixta de enfermedad de Alzheimer junto a lesiones de tipo vascular (Pascual-Millán, 2002).

En la presente unidad didáctica se utiliza para la descripción clínica neuropsicológica de los distintos síndromes de demencia la clasificación etiopatogénica, diferenciando las principales demencias degenerativas primarias, cortical y/o subcorticalmente, y las demencias secundarias.